Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Costa Rica - Segunda Vara

Vistos os
Autos 0801077-47.2018.8.12.0009
Ação: Procedimento Comum Cível/PROC
Autor: Carolina Moreira Silva
Réu: São Francisco Sistema de Saúde Sociedade Empresária Ltda

S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,, interposta por Carolina Moreira Silva contra São Francisco Sistema de Saúde Sociedade Empresária Ltda, devidamente qualificados, para cobertura do tratamento quimioterápico, consultas e exames e danos morais pelo sofrimento advindo da negativa de tratamento.

A liminar para a realização dos procedimentos foi deferida a fls. 37 considerando tratar-se de tratamento médico de emergência, definido consoante a lei de regência da ANS, a englobar tratamento com risco de vida à paciente.

A Contestação a fls. 44 afirmou a improcedência dos pedidos porque a autora teria se equivocado ao sustentar que o prazo de carência fosse de apenas 24 (vinte e quatro) horas, apenas por ser o tratamento de emergência. Entende o réu que o atendimento de emergência, cuja carência é reduzida para 24 (vinte e quatro) horas, refere-se apenas e tão somente a atendimento ambulatorial, pelo período de doze horas ou até que evolua para internação, não se incluindo, no conceito de tratamento de emergência, cirurgia, internação, tratamentos nem

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código lWdGZmYy.

procedimentos especiais e complexos. Nesse sentido, a Defesa apresenta o artigo 2º da Resolução 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, que diz exatamente isso, para demonstrar a tese de que a carência de 24h em emergências alcançaria apenas o tratamento ambulatorial, fls. 48.

A autora impugnou a contestação a fls. 133, trouxe Jurisprudência de casos similares, no sentido de exigir a previsão contratual de carência de 24h para emergências e urgências. Requereu a produção de prova testemunhal, principalmente para demonstrar a ocorrência de sofrimento moral, os depoimentos foram colhidos na audiência de fls. 156.

Em Alegações Finais, fls. 157, o plano de saúde defendeu a carência de 180 dias, repisando que a carência de 24h é apenas para tratamento ambulatorial, fls. 159, não abarcando procedimentos de internação ou complexos; e afasta a hipótese de ocorrência de danos morais.

A autora por sua vez, apresentou Alegações Finais a fls. 160 onde agitou o conceito de emergência, que justificaria o atendimento da autora nas condições do caso concreto. Para a autora o pleito tem amparo na (mesma) Resolução 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, porém a partir da perspectiva dos artigos 1º e 5º que asseguram " a cobertura integral, ambulatorial e hospitalar para urgência e emergência". Em seguida traz a própria Lei 9.656/98 e Jurisprudência.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código IWdGZmYy.

É o relatório. DECIDO.

São pontos não controvertidos a existência do plano de saúde, as datas de início do contrato, a data do pedido, a necessidade do tratamento e a data do requerimento para cobertura dos exames e tratamento da autora.

Então, o ponto controvertido é a existência ou não de cobertura na data em que a autora precisou dos exames e tratamentos. Diagnosticada a moléstia, constatada a necessidade dos exames e do tratamento, a cobertura estava vigente para a autora? A autora entende que sim, pois o prazo da cobertura para a hipótese concreta seria o de 24 horas para emergências. Já o réu entende que o prazo correto a ser aplicado seria o de 180 dias da cláusula geral uma vez que o atendimento de emergência durante o período de carência limitar-se-ia ao ambulatorial.

A leitura do artigo 2º da Resolução CONSU destacado pela Defesa a fls. 48 é clara no sentido de que os planos ambulatoriais cobrem apenas as primeiras 12 horas e seu parágrafo único estipula que os planos ambulatoriais não cobrem a internação hospitalar.

> Art. 2º - O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.
>
> Parágrafo único. Quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código IWdGZmYy.

da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora.

Contudo o plano contratado é hospitalar. Evidente da descrição do plano, a fls. 20, que se trata de plano ambulatorial e hospitalar com obstetrícia:

6. OPÇÕES DE PLANOS

Assinale a Opção	Planos	Registro ANS	Abrangência Geográfica	Acomodação	Área de atuação do Plano de Saúde
X	Pleno 410 E	467.601/12-7	Grupo de Municípios	Coletiva	Araraquara/SP, Jaboticabal/SP, São Carlos/SP, Ribeirão Preto/SP, Sertãozinho/SP, Campo Grande/MS, Dourados/MS, Três Lagoas/MS, Rondonópolis/MT, Rio Verde/GO e Mineiros/GO.
	Pleno 410 A	467.600/12-9	Grupo de Municípios	Individual	
	Integrado 410 E	467.599/12-1	Grupo de Municípios	Coletiva	Araraquara/SP, São Carlos/SP, Ribeirão Preto/SP, Sertãozinho/SP e Campo Grande/MS.

Segmentação Assistencial: Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia — **Fator Moderador:** Coparticipacão

Coparticipação: Além das Mensalidades, sempre que houver utilização de serviços Médicos e hospitalares será cobrada a Coparticipacão de acordo com o plano escolhido pelo contratante, conforme tabela prevista em contrato.

A Defesa buscou aplicar o artigo 2º, da Resolução 13/98, do CONSU, que regula o plano ambulatorial, combinado com o art. 3º, §1º, que estipulava a carência para emergências.

Com efeito, o plano hospitalar está regulamentado pelo artigo 3º da Resolução de 1998.

> Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções.
>
> §1º. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código lWdGZmYy.

de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação.

§2º. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato.

§3º. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora.

Percebe-se do art. 3º, §1º, da Resolução 13/98, que durante a carência o atendimento de emergência reger-se-ia pelas regras do plano ambulatorial, ou seja, do artigo 2º antes reproduzido.

Assim, apenas da leitura da Resolução 13/98 do CONSU, poder-se-ia entender que em casos de emergência dentro do período contratado de carência - de 180 dias – aplicar-se-iam as regras do plano ambulatorial.

Esse é o argumento da Defesa.

Porém tal argumento não é válido. A Resolução 13/98 do CONSU é mero regulamento e deve ser interpretada em consonância com a Lei 9656/98. A redação do art. 12, §2º, da Lei 9656 em 1998 realmente fazia essa distinção por meio de definição autêntica dos termos urgência e emergência e, via de consequência, naquela época o respectivo regulamento (Resolução 13/98 – CONSU) seguia a diretriz legal. Vejamos a redação revogada da Lei 9656/98:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código IWdGZmYy.

> §2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
> I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
> II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

Entretanto, após a Medida Provisória 2.177-44 /2001 essa definição foi abandonada. A Lei 9656/98 passou a prever que:

> Art. 12, V, quando fixar períodos de carência:
> (c) - prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

E ainda depois disso em 2009:

> Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei 11.935, de 2009)
>
> I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)
>
> II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei 11.935, de 2009)
>
> III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei 11.935, de 2009)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código IWdGZmYy.

O contrato é de 2018. À evidência, deve ser interpretado à luz da Lei com a redação vigente após 2009. Querer aplicar a redação do regulamento de 1998 contra a disposição de Lei de 2009 é pretender subverter tanto a hierarquia das normas jurídicas quanto a regra prevalência da norma mais recente. Tenho estampada a má-fé no sentido de buscar deduzir defesa contra texto expresso de lei, o que é vedado na forma do art. 80, I, do CPC.

Clara é a Lei ao estabelecer a obrigação de cobertura após 24 horas para casos de emergência e urgência. Assim diz a Lei acima transcrita e aqui sintetizada: É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. E, quando fixar quando fixar períodos de carência, o prazo máximo será de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. (art. 12, V, 'c', c/c art. 35-C, I, da Lei 9656/98, com a redação na data do contrato).

De fato, a legislação de regência é bastante específica, e por isso ao pedir a aplicação do regulamento com a redação de 1998, ou seja, antes da reforma da Lei, poderia a Defesa induzir a erro o julgador, enredado em metas que preveem dezenas de sentenças por semana. O dever de lealdade processual é exigido pelo art. 5º, do CPC, para que se evite induzir o erro por meio, por exemplo, da conduta tida pelo art. 80, I, do CPC, como reprovável como vista neste caso do manejo de pedido contrário ao texto da Lei.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código IWdGZmYy.

Em síntese, restou demonstrada a emergência para a realização dos exames e do tratamento, seja porque a agressividade da doença caracterizava o risco à vida e o risco de sequelas à paciente, seja pelo expresso reconhecimento pela declaração médica de fls. 25.

No mesmo sentido a Jurisprudência do TJMS colacionada pela autora a fls. 07, Apelação 0002643-43.2009.8.12.0021, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Vilson Bertelli, j: 15/07/2014, p: 08/08/2014. Bem como a de outros tribunais a fls. 164 nas Alegações Finais. Ademais, nos moldes do art. 489, VI, do CPC, a observância do precedente invocado pela parte é de rigor.

Por todo o exposto, porque se tratava de caso de emergência e porque a carência máxima permitida pela lei de regência é de 24h, a cobertura era devida para a autora no caso em tela. Procedente pois o pedido principal de mérito.

Ao lado disso cumpre registrar que a negativa com fundamento na aplicação da carência com prazo de 180 dias, e, aplicação da sistemática de emergência prevista para o plano ambulatorial, pela incidência da cláusula do atendimento de emergência (do art. 3º, 1º, da Resolução 13/98), é frontalmente contrária ao texto expresso da Lei de regência 9656/98 com a redação de 2001 em diante.

Não obstante, é isso que trouxe a Contestação de 2018 a fls. 47.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código IWdGZmYy.

Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Costa Rica - Segunda Vara

DA COBERTURA CONTRATUAL EM CASOS DE URGÊNCIA

Equivoca-se a Autora ao sustentar que o prazo de carência é de apenas 24 (vinte e quatro) horas, haja vista a gravidade da patologia necessitando, portanto, de tratamento urgente.

O atendimento de urgência e emergência, cuja carência é reduzida para 24 (vinte e quatro) horas, refere-se apenas e tão somente a **atendimento ambulatorial, pelo período de doze horas ou até que evolua para internação, não se incluindo, desse modo, cirurgia, internação, tratamentos e os exames/procedimentos especiais e complexos.**

Reitera-se que não se trata de atendimento de forma ilimitada, não engloba, de forma alguma, internação, cirurgia, tratamentos ou exames/procedimentos especiais e complexos

O atendimento de **urgência e emergência com carência de 24 (vinte e quatro) horas, não é, portanto, ilimitado.**

O atendimento de urgência e emergência, cuja carência é reduzida para 24 (vinte e quatro) horas, refere-se apenas e tão somente a **atendimento ambulatorial, pelo período de doze horas.**

Para internação, tratamentos, exames/procedimentos especiais e complexos, bem como cirurgia, há que ser respeitado o prazo de carência estipulado contratualmente, ou seja, 180 dias.

Desse modo, sob mais esse ângulo, de rigor a improcedência do presente feito.

E arremata, com menção expressa aos termos do regulamento de 1998 por duas vezes derrogados, ante a Medida Provisória 2.177-44 de 2001 e a Lei 11.935 de 2009 :

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código IWdGZmYy.

É o que dispõe a **Resolução nº 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU**, que regula ***a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência***.

Nos termos do artigo 2º da mencionada Resolução:

> "***O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.***
>
> ***Parágrafo único. Quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora."***

Note-se que o próprio Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, responsável por fiscalizar as atividades das operadoras de saúde, legitimam a conduta da Ré.

Dessa forma, como antes exposto, tenho configurada a litigância de má-fé, motivo pelo qual de ofício, na forma do art. 81 do CPC fixo a multa no valor de 2% do valor corrigido dado à causa.

Passo à análise dos pedidos acessórios de reparação pelos danos morais. A autora requer a condenação pelos danos morais sofridos em razão da negativa de tratamento pela empresa ré.

É importante anotar que os danos morais não são devidos em razão do sofrimento acarretado pela doença. A doença é fato imprevisível e aleatório, caso de força maior, não sendo as dores da enfermidade passíveis de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código IWdGZmYy.

responsabilidade civil.

O que se analisa aqui são os danos morais decorrentes do atraso no tratamento decorrentes da negativa ilegal do tratamento médico devido pela ré. Ante a negativa injusta de adimplemento dos termos do contrato de saúde a autora teve aumentado o seu sofrimento. Os danos decorrentes do agravamento dos efeitos da doença em razão do tempo desnecessariamente gasto com o enfrentamento da ilegalidade perpetrada pela ré, bem como o sofrimento decorrente do agravamento dos sentimentos de medo, impotência, ansiedade em razão da resistência da empresa em prestar o serviço devido. Temos portanto três elementos a serem reparados: (1) o sofrimento devido pelos sintomas da doença que poderiam ter sido antes mitigados ou curados se tempestivo o atendimento; (2) o sofrimento pelas maiores sequelas decorrentes pelo agravamento do carcinoma, tido como extremamente agressivo nos laudos médicos, pela ausência de pronto atendimento; e (3) sofrimento pela necessidade de precisar enfrentar a injustiça inflingida à autora justamente no momento em que precisava concentrar seus esforços e diligências no combate à doença.

O câncer é doença reconhecida como gravíssima, com sintomas devastadores, sendo inclusive severos os sintomas do próprio tratamento. Assim, tenho por elevado o dano moral sofrido no item (1) acima.

A demora no tratamento, item (2), oportunizou alastramento da doença que não ocorreria se o atendimento fosse tempestivo, os efeitos desse

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código lWdGZmYy.

agravamento desnecessário do câncer de mama além do maior risco à vida repercutem na esfera estética e na própria imagem que a autora tem de si mesma. Aqui também severos os danos morais a serem reparados.

Por fim, o esforço consumido pela autora para diligenciar na luta por seu direito ao tratamento contratado lhe mitigou o escasso tempo de que dispunha para lutar por sua sobrevivência. A Doutrina do Desvio Produtivo do Consumidor tem sido acolhida para a reparação do tempo despendido em busca da defesa de direitos, sendo commodity cada vez mais escassa, o tempo perdido deve ser reparado. Mais grave no contexto de necessidade de enfrentamento de câncer, sendo melhor aproveitado o recurso para a realização de exames, agendamentos, consultas, tratamentos e recuperação do que para resgate do direito contratado justamente para esses fins.

Finalmente, registra-se que o fundamento de danos extrapatrimoniais de caráter punitivo não é utilizado como fundamento desta sentença. Ainda que defendido por parcela relevante da Doutrina, destaque para Farias, Rosenvald e Netto, Curso de Direito Civil, vol. 3 - Responsabilidade Civil (7ª ed.). Salvador: JusPodivm. , 2020, p. 379-431. Deixo de analisar essa dimensão dos danos morais porque o valor pleiteado pela autora é sobremaneira inferior aos gastos com o tratamento. E o vetor fundante da doutrina da indenização punitiva é que a reparação deve ser superior ao benefício auferido com a irregularidade, pois valor inferior ao ganho não é sanção mas incentivo. No caso, não haveria qualquer efeito punitivo em reparação no valor pleiteado pela Inicial uma vez que inferior aos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código IWdGZmYy.

custos do tratamento sonegado à autora.

Considera-se aqui os fatores da capacidade econômica da empresa ré, dos danos efetivamente sofridos pela autora bem como a conduta da ré, ou seja, o grau de culpa percebido no comportamento de deixar de cumprir o contrato. Verifica-se todos em grau elevado. Trata-se de empresa de grande porte, os danos são gravíssimos inclusive com risco à vida da autora bem como a prática de deixar de prestar o atendimento se aproveitando da situação de emergência e do estado de perigo.

Portanto, dou provimento ao pedido de reparação de danos morais, com fins exclusivamente de reparação dos prejuízos efetivamente suportados pela autora, pois demonstrados na instrução o fato gerador e o nexo causal, sendo arbitrado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com fundamento nos elementos colhidos na instrução em audiência, bem como na presunção *in re ipsa* dos danos extrapatrimoniais suportados.

Em síntese, julgo procedente a ação, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela de urgência antecipada e condenar a empresa ré à prestação do atendimento médico de emergência; para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais; a condenar a empresa ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 2% do valor dado à causa. Os danos morais devem ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir desta data na forma da Súmula STJ 362. E o termo inicial dos juros de mora é a data do evento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código IWdGZmYy.

Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Costa Rica - Segunda Vara

danoso, no caso a negativa do atendimento, fls. 32, por se tratar de responsabilidade extracontratual, na forma da Súmula STJ 54.

Custas e honorários pelo sucumbente, art. 85 do CPC. Honorários em 10% (dez porcento) do valor da condenação, considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, máxime porque o processo teve curso regular sem nada a discrepar do trâmite normal, motivo pelo qual resultam arbitrados em patamar médio.

Às providências. Expeça-se o necessário.

P. R. I. C. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo após o trânsito em julgado desta sentença.

Costa Rica, 22 de fevereiro de 2021.

Marcus Abreu de Magalhães
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 23/02/2021 às 13:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-47.2018.8.12.0009 e código IWdGZmYy.